

Laringitis y Crup

1. Introducción y relevancia clínica

La **laringitis aguda viral**, también conocida como **crup**, es una infección de las **vías respiratorias altas**, que causa **inflamación de la laringe, tráquea y bronquios proximales**, produciendo **estridor inspiratorio, tos “perruna” y disfonía**.

Afecta principalmente a **niños entre 6 meses y 3 años**, aunque puede verse hasta los 6 años.

Su importancia clínica radica en que puede producir **obstrucción respiratoria aguda potencialmente grave**, especialmente en lactantes pequeños.

En Chile, es una causa frecuente de consulta en urgencias respiratorias durante el invierno, y está incorporada dentro del **Programa IRA (MINSAL)**, que estandariza su diagnóstico y manejo.

En el **EUNACOM**, se pregunta con frecuencia bajo el formato:

“Niño de 2 años, con tos metálica, disfonía y estridor nocturno súbito; manejo inicial correcto.”

2. Fisiopatología y bases conceptuales

El crup se produce por infección viral que genera **edema subglótico** (por debajo de las cuerdas vocales), lo que causa **obstrucción progresiva del flujo aéreo**.

a. Agentes etiológicos

- **Virus parainfluenza tipo 1 (más frecuente).**
- Parainfluenza 2 y 3.
- Virus respiratorio sincicial (VRS).
- Adenovirus.
- Influenza A y B.
- SARS-CoV-2 (raro, pero descrito).

b. Fisiopatología

1. El virus infecta la mucosa respiratoria superior → inflamación de laringe y tráquea.
 2. El **edema subglótico** reduce el diámetro de la vía aérea.
 3. Dado que el flujo aéreo depende del **radio⁴ (Ley de Poiseuille)**, un pequeño edema genera una gran resistencia, especialmente en niños pequeños.
 4. Esto se traduce en **estridor inspiratorio, tiraje y aumento del esfuerzo respiratorio**.
-

3. Clínica (signos, síntomas y diagnóstico diferencial)

a. Cuadro clínico típico

- **Inicio gradual**, precedido por cuadro catarral leve.
- **Tos “perruna” o metálica** (similar a sello de perro).
- **Disfonía o ronquera**.
- **Estridor inspiratorio** (al comienzo solo con el llanto, luego en reposo).
- **Fiebre baja o ausente**.
- **Dificultad respiratoria nocturna**, con mejoría diurna.

b. Clasificación de gravedad (según MINSAL / Westley Score)

Gravedad	Estridor	Tiraje	Tos/disfonía	Estado general	Manejo
Leve	Solo con llanto	Leve o ausente	Tos ronca, leve	Buen estado general	Ambulatorio, corticoide oral
Moderada	En reposo	Retracciones moderadas	Disfonía marcada	Inquietud	Corticoide + adrenalina nebulizada

Grave	Estridor en reposo, cianosis, quejido	Retracciones intensas	Fatiga, hipoxemia	Somnolencia o agitación	Urgencia hospitalaria, adrenalina + O ₂
Amenazan te	Silencio respiratorio, bradicardia	—	—	Compromiso de conciencia	Intubación / UCI

c. Diagnóstico diferencial

Patología	Diferencias principales
Epiglotitis (H. influenzae b)	Inicio súbito, fiebre alta, babeo, posición en trípode, sin tos; urgencia vital
Laringotraqueobronquitis bacteriana (S. aureus)	Fiebre alta, toxicidad, mal estado general
Cuerpo extraño	Inicio brusco, sin fiebre, antecedente claro
Traqueítis bacteriana	Tos purulenta, fiebre, evolución tórpida
Espasmo laríngeo nocturno (crup espasmódico)	Recurrente, sin fiebre, cede espontáneamente

4. Exámenes complementarios y criterios diagnósticos

a. Diagnóstico

El diagnóstico de **crup es clínico**, no requiere exámenes.

No está indicada la radiografía ni laboratorio en la mayoría de los casos.

b. Exámenes complementarios (solo si duda diagnóstica o evolución grave)

- **Oximetría de pulso:** valorar hipoxemia.
- **Rx de cuello AP/lateral:** “signo del campanario” (estrechamiento subglótico).
- **PCR viral:** en pacientes hospitalizados o brotes institucionales.

5. Tratamiento (según Guías MINSAL / SOCHIPE 2024)

a. Medidas generales

- Mantener al niño **tranquilo y en posición de confort**.
- **Oxígeno húmedo** solo si $\text{SatO}_2 < 92\%$.
- No realizar procedimientos innecesarios (evitar llanto o manipulación).

b. Tratamiento farmacológico

Situación	Medicamento	Dosis y vía	Observaciones
Todos los casos (leve a grave)	Corticoide sistémico (dexametasona o prednisolona)	Dexametasona 0,15–0,6 mg/kg VO/IM/EV (máx. 10 mg)	Mejora síntomas en 2–3 h, evita recurrencias
Moderado-grave	Adrenalina racémica nebulizada (1:1.000)	0,5 mL/kg diluido en 3 mL SF, máx. 5 mL; repetir cada 20–30 min si persiste	Reduce edema rápidamente (efecto 2 h)

Hipoxemia	Oxígeno por cánula o máscara	—	Mantener SatO ₂ ≥94 %
No recomendados	Antibióticos, antitusivos, sedantes, vapor frío	—	No demostraron eficacia

c. Observación y alta

- Observar **2–3 horas** post adrenalina nebulizada (por efecto rebote).
 - Si no hay estridor en reposo ni dificultad respiratoria → alta.
 - Instruir a los padres sobre signos de alarma (estridor persistente, cianosis, somnolencia).
 - Reforzar hidratación, ambiente tranquilo y control médico si recurre.
-

6. Complicaciones y pronóstico

a. Complicaciones

- Obstrucción respiratoria severa.
- Hipoxemia o insuficiencia respiratoria aguda.
- Neumonía secundaria (rara).
- Intubación o traqueostomía en casos extremos.

b. Pronóstico

El pronóstico es **excelente**, con resolución completa en 3–7 días.
 La mortalidad es extremadamente baja (<0,1 %).
 Recurrencias son frecuentes (crup espasmódico).

7. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM

□ Perlas:

1. **Tos metálica + disfonía + estridor nocturno = crup viral** (diagnóstico clínico).
2. **Agente más frecuente:** parainfluenza tipo 1.
3. **Tratamiento principal: dexametasona** (0,15–0,6 mg/kg VO o IM).
4. En casos moderados o graves, agregar **adrenalina racémica nebulizada**.
5. **No se usan antibióticos ni vapor frío.**
6. Observar **al menos 2 h post adrenalina** antes del alta.
7. **Epiglotitis** se diferencia por fiebre alta, babeo y ausencia de tos → urgencia vital.

□ Errores frecuentes:

- Administrar antibióticos o antitusivos innecesariamente.
 - No observar tras la nebulización con adrenalina.
 - No distinguir **epiglotitis (emergencia)** de crup viral.
 - Subestimar el riesgo de obstrucción en lactantes pequeños.
 - Usar nebulizaciones frías o vapor caliente sin evidencia.
-

8. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. El **crup viral** es una **laringotraqueítis aguda** causada principalmente por **virus parainfluenza tipo 1**.
2. Afecta a **niños de 6 meses a 3 años**, con tos “perruna”, disfonía y **estridor inspiratorio nocturno**.
3. El **diagnóstico es clínico**, sin necesidad de exámenes.
4. **Tratamiento: dexametasona (VO/IM/EV) + adrenalina racémica nebulizada** en casos moderados o graves.

5. **No se usan antibióticos ni vapor frío.**
6. Observar 2–3 h tras adrenalina antes del alta.
7. **Epiglotitis (Hib)** es el principal diagnóstico diferencial y **emergencia vital**.